جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : سمر محمود محمد مرسى
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** عابدين **العنوان :** ديروط
رقم البطاقة : 27811012500548 **رقم التليفون :** 01275622732 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 23-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 01-11-1978 **المهنة :** بدون عمل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام ماموجرام وسونار علي الثديين [10888] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: سمر محمود محمد مرسى
National ID: 27811012500548

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Bilateral mammogram and breast ultrasound**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Dr.
Elia Anis Ishak
M. Sc. Ph. D. Pathology - Prof. of Pathology , Cairo University
Fellow, Armed Forces Institute of Pathology , USA
Member, United States Canadian Academy of Pathology

Dr.
Shady Elia Anis
M. Sc. MD Pathology , Ass. Prof. of Pathology , Cairo University
Fellow , Mass General Hospital , Harvard , USA
Member , United States Canadian Academy of Pathology

Patient Name : سمر محمود محمد مرسى
Analysis ID : 693821
Age : 43 Y : 1 M : 1 D
Gender : Female
Referred By Prof. Dr. : حمدى عبد العظيم
Clinical Diagnosis : Left breast suspicious mass.
Nature of Specimen : US guided biopsy.
Receiving Date : 2022-10-17
Patient ID : 535142

PATHOLOGY REPORT

Gross :

multiple greyish white tissue cores, the longest measured 1.2 cm, totally submitted.

Microscopic :

Serial sections examined from specimen received revealed cores of tumor tissue formed of groups of malignant ductal cells showing moderate nuclear pleomorphism and hyperchromasia.There is moderate tendency to tubular formation.
The mitotic index is low.
There is marked desmoplasia and marked hyalinosis.
There is peritumoural lymphocytic infiltrate around 5%.
There is no necrosis. No intraductal component.

Diagnosis :

Left breast suspicious mass, US guided biopsy, INFILTRATING DUCT CARCINOMA, GRADE II.

Prof. Dr. Shady Elia Anis

Prof. Dr. Elia Anis Ishak

This report is electronically signed , any abrasion or modification would render it void .

عمارة رمسيس - بلوك أ - ميدان رمسيس - الدور السادس و السابع
تليفون : ٢٥٧٩٠٩٣٥ - ٢٥٧٤٤٧٤٢ - ٢٥٧٧٣٢٥٣

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name: سمر محمود محمد مرسى	
MR. : 5671	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient underwent a bone scan in September 2025, which was reported as free pending. A CT of the chest, abdomen, and pelvis performed on 30-9-2025 was read as normal. The left operative bed demonstrated a local recurrence with a regressive course. The patient was prescribed FEMARA and calcium 1 × 1 × 90, and a single dose of ZOLADEX 10.8 mg was administered.

The patient presented for administration of ZOLADEX and FEMARA, with the latter intended for a three-month supply from the pharmacy.

The patient received ZOLADEX 10.8 mg and FEMARA (3 months) and pending investigations were noted, with a plan to follow up after three months.

Pending investigations were ordered for FEMARA and ZOLADEX 10.8 mg, and the next follow-up visit was scheduled for three months later.

تحريرا في ,

التاريخ :	19-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : ايه مدحت بدوي محمد

يعتمد ,

Patient Name	: الأستاذه / سمر محمود محمد مرسى	Request No.	: 13004348
Patient No.	: 27811012500548	Request Date	: 29/10/2022
Path No.	: SR-834/22	Verification Date	: 23/11/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اوراد نار السلام - نفقة الدولة
Age	: 43 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: Ali mostafa

Pathology Report

CLINICAL DATA
Left breast mass

NATURE OF SPECIMEN
Revision of tru cu: biopsy &IHC slides
GROSS EXAMINATION
One block (693821) + 5 slides.

MICROSCOPIC EXAMINATION
* Histological type: Invasive duct carcinoma.
* Grade (differentiation +nuclear pleomorphism+mitosis): (3+2+2) Grade II
* DCIS: No
* Angioinvasion: Could not be detected within the limits of biopsy received
IPT :
ER:strong nuclear staining in 20% of tumor cells(6/8)
PR:strong nuclear staining in 80% of tumor cells (8/8)
Her2: no memrane staining in tumor cells , score(0)
KI 67: Positive nuclear staining in 10% of tumor cells
DIAGNOSIS
Left breast mass ; slide revision of tru cut biopsy specimen :
Invasive duct carcinoma, Grade II .
IPT :
ER: positive (6/8)
PR:positive (8/8)
Her2: negative score(0)
Ki67: positive in 10 % of tumor cells

Signature
Prof. Dr. Amal Hareedy

Verified by :
saamah sayed

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: الأستاذه / سمر محمود محمد مرسى	Request No.	: 13004348
Patient No.	: 27811012500548	Request Date	: 29/10/2022
Path No.	: SR-834/22	Verification Date	: 23/11/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - ثقة الدولة
Age	: 43 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: Ali mostafa

Pathology Report

Dr.Heba Hassan

Verified by : Heba hassan

Verified by :
saamah sayed

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Cairo University
National Cancer Institute
Department of Diagnostic and
Interventional Radiology

جامعة القاهرة
المعهد القومي للأورام
قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية

Exam Information:

Patient Name: Samr Mahmoud	*Date of birth:* 01/11/1978
Arabic Name: سمر محمود	*Patient Gender:* F
Patient RIS ID: 286976	*Exam Date:* 21/01/2024
Patient HIS ID: 121020503	
Written by:	Approved by:
Dr. Hoda Fathy	Dr. Hoda Fathy

Nuclear Medicine Unit

وحدة الطب النووى

^{99m}Tc-MDP BONE SCAN

Brief history: 41 years old female patient diagnosed with managed breast cancer.

Desired Information: - skeletal survey.

Technique:

Delayed Whole body imaging in anterior and posterior projection performed 2 hours after I.V administration of 20 mCi ^{99m}Tc-MDP in the following manner:

Report:

- *No hot spot that account for osseous deposits could be detected allover the surveyed skeleton.*
- *Homogenous tracer distribution noted over axial and appendicular skeleton*

Bone Scan
[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]

مساعد رئيس الجهاز للشؤون الطبية
لقسم مدينة الملك الطبية

M T FORM 24 / 10 / 2022 G

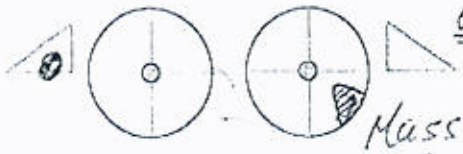
Name	[illegible]	MRN	٤٠٢٢ / ٤٠٦١
		ID	٤٧٨١١٠١٢٥٠٥٤٨
Age	43	Phone	٠١٠٩٦٢٥٦٤٩٠
Menopausal status		Marital status	
NRS SCORE	2	Family history	
BMI	obese II	REASON OF MDT	
CO morbidity			

Clinical Data: Isolat Recurrance + Contalat Axilla L

BX:

ER:	PR:	HER 2:	Ki67:

R



unRes Mass ↑ infiltrating the skin.

Sonomammography:
CT s → Lt breast Mass, Rt axilla LN's

Mets Workup:
- Bone scan → free
- Lt Breast bx → IDC ER = 7/8, PR = 8/8, HER2 = 0, Ki67 = (12%)

TNM

Recommendations:
29/10/2022 → - Trucu bx of Rt axilla LN.
- Bilat SM. (bring reports)
- 1st Line Mets (Zoladex/A.I)

MDT OUTCOME & PLAN
- Tumor Markers
- Cl. exam / mn.

- Revise [illegible] in [illegible]

3 months then re-evaluate

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPTE

Patient Name: Samar Mahmoud Mohamed Morsi	Date : 30/09/2025
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 47 Year(s)
Medical ID: 4061/2022	Pat. ID: 21689

Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast sonography revealed:

Clinical summary: Post left CBS and ALAND with pathologically proven operative bed recurrence, routine follow up study

Findings:

Right breast.

- Almost entirely fatty breast parenchyma. (ACR a)
- No speculations, masses asymmetry , distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Left breast.

- Almost entirely fatty breast parenchyma. (ACR a)
- UOQ architectural distortion with dystrophic calcifications, yet middle third irregular speculated high density mass lesion with no suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated UOQ area of parenchymal disruption underneath the operative scar with 2 o'clock middle third , irregular pathologically proven recurrent mass measuring 16 x 12 mm, invading the overlying skin.
- Normal nipple/areola complex.
- Clear left axilla. No pathological infra or supra-clavicular lymph nodes

Conclusion:-

Right breast (BIRADS 1): Normal study.

Left breast (BIRADS 6): operative bed local recurrence, showing regressive course.

Best Regards,
DR, Amal Hegazi, M.Sc.

BIRADS classification of breast lesions according to the American College of Radiology used for breast assessment combined with recommendations:

Category & recommendations	Suspected Cancer Risk
BIRADS 0: Non-informative study.	
BIRADS 1: Normal study, routing screening	0 %
BIRADS 2: Benign findings, routine screening	0 %
BIRADS 3: Probably benign, for close follow up.	2 %
BIRADS 4: Probably malignant, for biopsy.	50 %
A: mild suspicion.	
B: moderate suspicion.	
C: high suspicion.	
BIRADS 5: Malignant, for biopsy.	98-100%
BIRADS 6: Pathologically proven malignant	

Signature Dr. Amal Hegazy
AM 10:43 2025/09/30

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]